

13. PRIMITIVE KRANIOSAKRALE ACHSE

DAUER : 03:34

LEHRBLATT

KURSZUSAMMENFASSUNG

In diesem Video untersuchen wir ausführlich die primitive kraniosakrale Achse, die in der zweiten Woche der Embryonalentwicklung mit der Bildung der Chorda dorsalis entsteht. Die Lehre beleuchtet die Bedeutung dieser Struktur für den Schädel und das Kreuzbein, insbesondere indem sie hervorhebt, wie ein freies Kreuzbein unerlässlich ist, um die Funktionalität der Wirbelsäule und die Flexion-Extension der Schädelbasis zu gewährleisten. Darüber hinaus behandelt das Video die Auswirkungen dieser embryonalen Dynamik auf urogenitale Pathologien und wie die Lösung bestimmter emotionaler oder energetischer Blockaden zwischen dem Sigma und der Blase zu einem besseren Gesamtgleichgewicht beitragen kann. Die Studenten lernen, diese Konzepte zu manipulieren, um ihre Praxis in der Osteopathie und der biodynamischen Embryologie zu verbessern.

PRIMITIVER KRANIOSAKRALER ACHSE

In der zweiten Woche der Embryonalentwicklung beginnt die **S-Form** des Epiblastenprozesses die **Notochord** zu bilden. Der **Hensen-Knoten**, oder primitive Grube, wird zu einem fixen Stützpunkt und bewegt sich allmählich nach hinten.

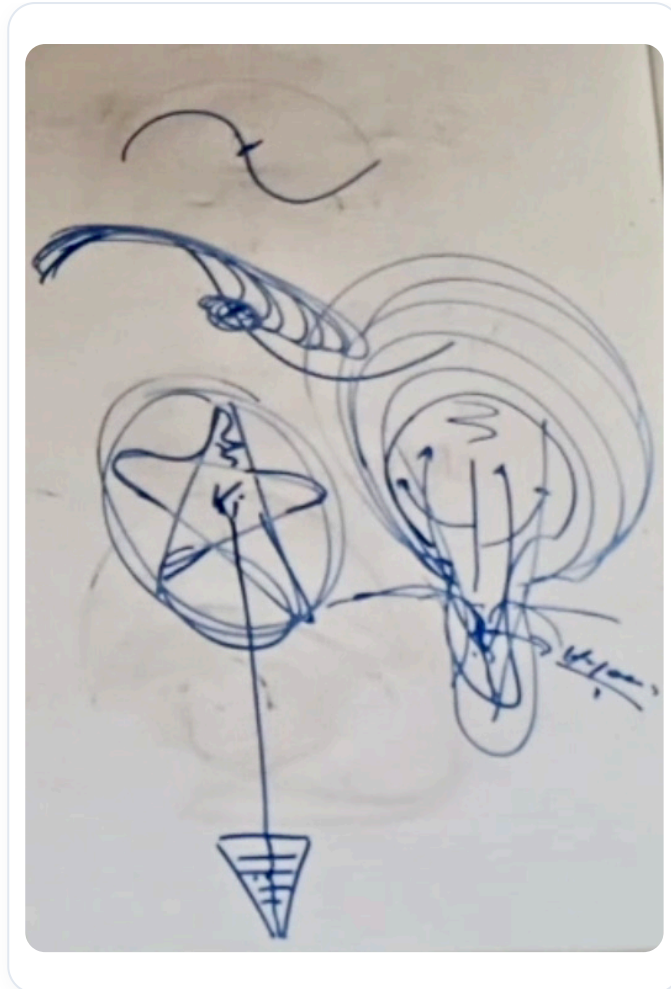


ABB. — Beginn des Epiblastenprozesses

Diese Struktur ist wesentlich, da sie die Basis des **Schädels** bildet und Elemente wie die **Hypophyse**, die **großen Keilbeinflügel**, das **Felsenbein-System**, das **Okzipital-System** und das **Siebbein** integriert. Unten beginnt die Entwicklung des **Kreuzbeins** mit dem S2-Prozess, der den Überrest der Primitivrinne darstellt. Dieser Prozess wird zu einem entscheidenden Stützpunkt und unterstreicht die Bedeutung eines **freien Kreuzbeins** für eine funktionelle Einheit.

In dieser Entwicklungsphase nimmt der Embryo eine schlägerähnliche Form an, mit der Notochord und der Primitivrinne. Dieser Wachstumsprozess erzeugt ein Aspirationsfeld zur Bildung des **Mesoderms**, insbesondere des präkardialen Feldes. Das anteriore Wachstum des Embryos saugt Material in diesen Bereich, wodurch **Flaschenzellen** zum Zentrum gezogen werden. Diese Zellen setzen **Hyaluronsäure** frei, die auf mesenchymaler Ebene essentiell ist.

Die Notochord-Achse ist grundlegend, da sie die Bewegungsfreiheit des Kreuzbeins beeinflusst. Ist das Kreuzbein blockiert, kann die Wirbelsäule nicht richtig funktionieren, was die Schädelbasis beeinträchtigt. Eine nicht freie Schädelbasis verhindert eine gute **Flexion-Extension**, was zu einem Ungleichgewicht zwischen **Neurokranium** und **Viszerokranium** führt.

Diese Dynamik hängt mit der aufsteigenden Kraft des Schädels zusammen, wo sich das Auge einnistet, und mit der Etablierung eines **mesodermalen Gewebes**. Das ektodermale Wachstum zieht nach oben, während der Primitivknoten zum Kreuzbein absteigt. Dies schafft einen

wichtigen Bereich für Proteininformationen in Bezug auf die Mutter.

Viele blockierte **Ahnenbilder** befinden sich zwischen dem Sigma und der Blase, wo es entscheidend ist, diese Informationen zu klären. Urogenitale Probleme können durch diese Informationen übertragen werden, und die absteigende sakrale Migrationskraft spielt eine Schlüsselrolle in diesem Prozess.